

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Pancreatitis - Operation for Acute Necrotizing Pancreatitis

الحاد التهاب البنكرياس-جراحة علاج التهاب البنكرياس النادر

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure. (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:
Removal of gangrene and infection from the pancreas gland which may require partial removal of the gland itself. Further operations may be needed to remove all the diseased tissue, which may be over a 2-3 week period.

C. Risks of an operation for acute necrotizing pancreatitis

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following:

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return

1. المترجم / الاحتياج الثقافي
الحاجة لخدمات الترجمة نعم ☐ لا ☐
إذا كانت الإجابة بنعم ، هل هناك مترجم حاضر ؟ نعم ☐ لا ☐

ب . الحالة المرضية والعلاج
لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من :
يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض)

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق - يشمل ذلك موضع و/ أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

سيتم القيام بالتالي :
في هذا الإجراء تتم إزالة الأجزاء المصابة بالغرغرينة (الميتة) والمصابة بالعدوى من غدة البنكرياس و هو الإجراء الذي قد يتطلب استئصال كامل الغدة أو جزء منها.
قد تكون هناك حاجة لعمليات جراحية أخرى لإزالة كل النسيج المريض وذلك في غضون 2-3 أسابيع.

ج . مخاطر التهاب البنكرياس-جراحة علاج التهاب البنكرياس النادر
لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

مخاطر عامة:

- قد يحدث التهاب ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).

- Small areas of the lung can collapse increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Pancreatitis can be a life threatening condition. Formation of pancreatic fistula with pancreatic juice leaking onto abdominal wall. This may take some weeks to seal across and may cause skin irritation.
- The pancreatic tissue and surrounds may be severely damaged and become dead tissue, and extensive tissue removal may be necessary.
- Patient may develop a hernia and may require skin grafting to close the abdomen. This may cause scarring and permanent disfigurement.
- Damage of the bowel may occur which may cause leakage of bowel fluid. This may require further surgery.
- The abdominal wound may have to be left open to allow adequate drainage.
- Deep bleeding in the abdominal cavity could occur and this may need fluid replacement or further surgery.
- Infections such as pus collections can occur in the abdominal cavity. This may need surgical drainage.
- The bowel movement may be paralysed or

- العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتن أو اساسانتين)
- قد يحدث إنسداد للشعب الهوائية الصغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة، تزداد مخاطر الإصابة بالتهاب الجرح والصدر، مضاعفات في القلب والرئة، وجلطات الأوعية الدموية
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم يسبب ألم وتورم في الساق، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر متعلقة بهذا الإجراء:

- قد يكون التهاب البنكرياس من الحالات المرضية المهددة للحياة. تكون ناسور البنكرياس وتسرب عصارة البنكرياس على الجدار البطني قد يستغرق أسابيع ليخلق بإحكام وقد يسبب تهيج للجلد.
- نسيج البنكرياس والأجزاء المحيطة به قد تتعرض لضرر شديد وقد تصبح أنسجة ميتة. قد تكون هناك حاجة لإزالة واسعة للأنسجة.
- قد يظهر عند المريض فتق وقد يحتاج جراحة ترقيعية للجلد لإغلاق البطن. قد يسبب ذلك ندباً وتشوهاً دائماً.
- ضرر يصيب الأمعاء مسبباً تسرب لسوائل الأمعاء، مما قد يتطلب جراحة أخرى.
- قد تكون هناك حاجة لترك جرح البطن مفتوحاً للسماح بالتصريف الكافي للسوائل.
- نزيف عميق في التجويف البطني قد يستدعي إعطاء سوائل لتعويض الدم المفقود أو جراحة أخرى.
- الإصابة بالتهاب سوائل البطن كتجمعات للصدف في التجويف البطني مما قد يتطلب تفريغ الصديد جراحياً.
- قد تصاب حركة الأمعاء بالانسداد وبطء الحركة بعد

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

blocked after surgery and this may cause building up of fluid in the bowel with distension of the abdomen and vomiting. Further treatment may be necessary for this.

- A weakness can occur in the wound with complete or incomplete, bursting of the wound in the short term, or a hernia in the long term. This may require further surgery.
- In some people healing of the wound may be abnormal and the wound can be thickened and red and the wound may be painful.
- Adhesions (bands of scar tissue) may form and cause bowel obstruction. This can be a short term or a long-term complication and may need further surgery.
- Recurrent severe pain can occur if the acute problem goes into a chronic phase.
- Long term problems can occur due to damage to the pancreas, e.g. diabetes mellitus, malabsorption of essential nutrients.

D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

العملية مما يسبب تراكم السوائل في الأمعاء وانتفاخ للبطن وتقيؤ. قد يتطلب الأمر علاج آخر.

- ضعف قد يعترى الجرح ويؤدي على المدى القريب إلى تمزقه بشكل جزئي أو كامل ، وعلى المدى البعيد قد يتسبب ذلك في نشوء فتق. قد يتطلب ذلك جراحة أخرى.

- عند بعض المرضى ، قد لا يلتئم الجرح بشكل طبيعي . قد تزداد سماكته ويصبح لونه أحمر ، وقد يكون مؤلماً.

- قد تحدث التصاقات (أحزمة من الأنسجة المتندبة) وتسبب انسداداً للأمعاء. قد يحدث ذلك على المدى القريب أو البعيد وقد يحتاج حلاً جراحياً.
- إذا دخل الالتهاب الحاد إلى المرحلة المزمنة ، فقد يعاني المريض من الأم شديدة متكررة.

- ظهور مشاكل طويلة الأمد بسبب تضرر البنكرياس كالسكري ، عدم اكتمال امتصاص العناصر الغذائية الضرورية

د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الإجراء
(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

هـ . مخاطر عدم القيام بالإجراء
(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

F. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed).

G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained:

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure/treatment options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct

و . التخدير
قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير. (يقوم الطبيب
المعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

ز . إقرار المريض
أقر بأن الطبيب قد شرح لي :
• حالتي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك
الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم
يكن متوقعاً . أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر
الخاصة بحالتي الصحية.

• التخدير المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أفهم المخاطر
بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
• الخيارات الإجرائية الطبية والعلاجية الأخرى ذات
الصلة والمخاطر المترتبة عليها.
• المسار الطبيعي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام
بالإجراء.
• عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى
تحسن حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية
عالية.

• قد يشتمل الإجراء نقل دم لي .
• احتمالية إزالة أنسجة أو دم ، وقد يستخدمان في تشخيص
أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق
المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.

• إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ،
فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو
حسب خطة الإنعاش المحددة لي .

• قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

**About Your Anaesthetic
Pancreatitis - Operation for Acute
Pancreatitis
Blood and Blood Products Transfusion**

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date: Time:

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:

Relationship to patient:

Date: Time:

Contact No:

مدرک تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق التعليمات التالية:

- ☐ نوعية التخدير المقدم لي
- ☐ التهاب البنكرياس-جراحة علاج التهاب البنكرياس الحاد
- ☐ نقل الدم أو مشتقات الدم لي

• منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتى والتعبير عن مخاوفى فيما يخص حالتى المرضية والإجراء المقترح ومخاطره , والخيارات المتوفرة لعلاجى. وقد تم الرد على استفساراتى ومخاوفى بما حقق لي الرضا.

• أتفهم أن من حقى تغيير رأيى فى أى لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيعى لهذا النموذج , ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبى.

• أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وأن ذلك سيتم خلاله, وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج. وبناء على ما تقدم, فإننى أوافق على الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

المرضى فاقدى القدرة على إعطاء الإقرار يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب ينوب عنه ويملك المقدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح أدناه.

اسم من ينوب/ينوبون عن المريض فى اتخاذ القرار:

التوقيع:

صلته بالمريض:

التاريخ: الوقت:

رقم الإتصال:

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate: _____

Designation: _____

Signature: _____

Date: _____ Time: _____

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

ح . بيان الطبيب / مندوب الطبيب

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار المريض (ز) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب: _____

طبيعة الإنابة: _____

التوقيع: _____

التاريخ: _____ الوقت: _____

توقيع الشهود :

1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت : _____

2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت : _____